

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°146 /MVE-BDBV/07/10/2026

Date du rapport : 07 octobre 2026

Date de publication : 08 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Cinquante-neuf (59) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 26 décès communautaires, ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (29 cas), du Nord-Kivu (26 cas) et du Haut Uele (4). De plus, 11 décès ont été enregistrés dans les CTE
- Un total de 393 nouveaux échantillons a été analysé ; 59 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 15,0 % de positivité.

CUMUL DES
CAS
8 787

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
4 242

LETALITE
48,3 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
980

CUMUL DES
GUÉRIS
2 292

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
80,0%



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



**64 Zones de santé
touchées sur 167
(38,3%)**

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

59 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont 26 décès communautaires ont été notifiés dans 3 provinces : l'Ituri (29 cas) et le Nord-Kivu (26 cas) et au Haut Uele (4).

De plus, 11 décès ont été enregistrés dans les CTE (4 en Ituri, 4 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo) au Haut Uele (2), ce qui porte à 37 le nombre total des décès confirmés pour la période concernée.

En revanche, 23 patients (15 en Ituri et 8 au Nord Kivu) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

En date du 07 octobre 2026, la RDC cumule **8 787** cas confirmés et **4 242** décès, soit une létalité de **48,3 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **74,5 %** des cas confirmés cumulés et **49,2 %** des nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24 heures.

64 zones de santé sur 167 (38,3 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 07 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	29	6542	3 025	46,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	26	1811	1 036	57,2%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	4	368	156	42,4%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	0	51	19	37,3%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	59	8 787	4 242	48,3%	64/167 (38,3 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 07 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6542	3025	46,2%	29	14	4	18
Adja	12	1	8,3%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	210	47	22,4%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1797	596	33,2%	7	1	1	2
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	176	107	60,8%				0
Lita	295	148	50,2%				0
Logo	14	7	50,0%	0	0	1	1
Lolwa	35	9	25,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	41	17	41,5%				0
Mandima	209	105	50,2%	11	6	1	7
Mangala	366	157	42,9%				0
Mongbwalu	710	337	47,5%				0
Nia-Nia	316	177	56,0%	2	2	0	2

Nizi	799	289	36,2%	7	3	0	3
Nyankunde	132	39	29,5%	2	2	0	2
Rimba	14	5	35,7%				0
Rwampara	1118	386	34,5%	0	0	1	1
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1811	1036	57,2%	26	11	4	15
Beni	420	278	66,2%	11	8	2	10
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	289	182	63,0%	3	1	1	2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	63	22	34,9%				0
Katwa	613	374	61,0%	5	0	1	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%				0
Lubero	23	11	47,8%				0
Mabalako	52	20	38,5%	1	0	0	0
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	36	11	30,6%	2	0	0	0
Musienene	140	69	49,3%				0
Mutwanga	20	4	20,0%				0
Oicha	36	17	47,2%	2	1	0	1
Vuhovi	37	11	29,7%	2	1	0	1
Haut-Uélé	368	156	42,4%	4	1	2	3
Boma Mangbetu	44	19	43,2%	1	0	0	0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	95	46	48,4%	3	1	2	3
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	119	43	36,1%				0
Tshopo	51	19	37,3%	0	0	1	1
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	27	11	40,7%				0
Mangobo	8	5	62,5%			1	1
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0

Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8787	4242	48,3%	59	26	11	37

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.
NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 07 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	49	4	53	23	4	26	0	27	9
Bas Uélé	171	1	172	17	1	154	0	18	0
Ituri	1 143	71	1214	96	71	1 047	0	167	110
Nord-Kivu	1 529	63	1592	222	63	1 307	0	285	148
Sud Ubangi	31	1	32	1	1	30	0	2	0
Tshopo	134	0	134	7	0	127	0	7	0
Total Général	3 057	140	3 197	366	140	2 691	0	506	267

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

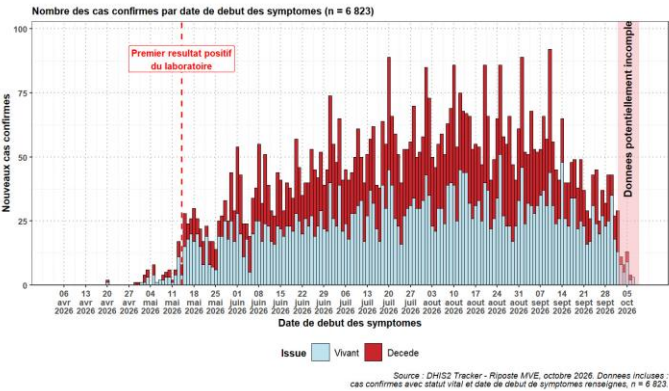
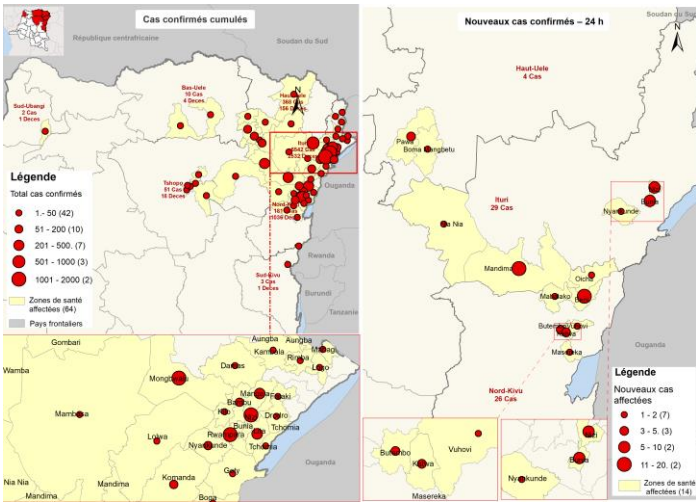


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour la journée du 07 octobre 2026, **3 197** alertes ont été rapportées dans les six provinces ayant notifié des alertes et toutes ont été vérifiées (**100,0 %**) : **506 (15,8 %)** ont été validées comme cas suspects et **2 691 (84,2 %)** invalidées. Les 506 cas suspects validés ont tous été investigués (100 %). Parmi eux, **267 (52,8 %)** ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Parmi 30 891 contacts en cours de suivi, 24 717 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de 80,0 %, en recul par rapport à la veille (82,0 %) et inférieure au seuil requis de 95,0 %. Par province, cette proportion était de 93,2 % (41/44) au Sud-Ubangi, 91,2 % (124/136) au Bas-Uélé, 89,2 % (222/249) à la Tshopo, 89,0 % (1 708/1 919) au Haut-Uélé, 83,0 % (11 141/13 427) en Ituri et 76,0 % (11 481/15 116) au Nord-Kivu. Aucune province n'atteint le seuil de 95 % et le Nord-Kivu reste le plus en retrait. Les ZS de Mutwanga (Nord-Kivu, 956 contacts) et de Makiso-Kisangani (Tshopo) n'ont pas transmis leur rapport de suivi.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Sept (7) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC repris au Tableau 4 le 07 octobre : trois (3) en Ituri, trois (3) au Nord-Kivu et une (1) à la Tshopo ; les 5 cas suspects validés ont tous été investigués dans les 24 heures. En Ituri, les deux alertes du PoC de Mudzi Bala (ZS de Bunia) ont été transférées au CTE CME et celle du PoC de Biakato Mai (ZS de Mandima) a été prélevée, son transfert ayant été refusé ; l'alerte du 28 septembre à Mudzi Bala s'est révélée positive. Au Nord-Kivu, l'alerte du PoC de Maboya (ZS de Kalunguta) a été validée et référée au CH Tinge, celle du PoC PK5 (ZS de Beni) invalidée, et un corps sans vie intercepté au PoC de Kasitu (ZS de Beni) a été acheminé à la morgue pour le swab

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 07 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	93,3% (56/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	94,9% (94/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	138 855	94 168	18 813	251 836
% des voyageurs screenés	95,0%	98,1%	98,6%	96,4%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,5%	98,1%	98,9%	97,8%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	98,1%	100,0%	99,1%
Nombre d'alertes notifiées	3	3	1	7
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	3	1	1	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	1	0	1
% des cas suspects transférés au CTE/CT	66,7%	100,0%	100,0%	80,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	100,0%	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2.2.2. Défis

- **Au Nord-Kivu**, le PoC de Butuhe ne fonctionne plus depuis l'incident sécuritaire du 26 septembre, la complétude des rapports reste à 95,2 % (20/21) et 1 821 voyageurs sur 94 168 (1,9 %) ont refusé le screening et le lavage des mains. À la Tshopo, 1,4 % des voyageurs (272/18 813) ont refusé le screening et 1,1 % (205/18 813) le lavage des mains, sur fond de rumeurs selon lesquelles « l'eau contient le virus » ou « la maladie n'existe pas ». Au Sud-Kivu, la complétude des rapports n'est que de 55,6 % (5/9). Au Bas-Uélé, seuls 19 PoC sur 41 sites de

notification sont fonctionnels (46,3 %), aucun PoE n'est renforcé (0/11), la complétude des rapports n'est que de 83,3 % (15/18) et les services du PNHF ne sont pas opérationnels.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 29 nouveaux résultats positifs** (15 vivants et 14 décès) sur 175 échantillons reçus et analysés (**positivité : 16,6 %**).
- **Nord-Kivu : 26 nouveaux résultats positifs** (15 vivants et 11 décès) sur 180 échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,4 %**).
- **Haut-Uélé : 4 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 1 décès) **sur 24 échantillons reçus et analysés**.
- **Tshopo : 10 nouveaux échantillons (10 sangs) reçus et analysés, tous sont revenus négatifs**
- **Bas Uélé : 4 échantillons** (4 sangs) reçus et analysés au laboratoire de Buta, **tous sont revenus négatifs**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 31 rings ont été ouverts sur 34 (91,2 %), 56 ménages décontaminés sur 57 (98,2 %) et 6 FOSA décontaminées sur 7 (85,7 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 106 alertes EDS (dont 8 reports de la veille), 78 EDS ont été réalisés (73,6 %) et 74 corps swabés, avec 22 échecs (20,8 %).
- **Nord-Kivu** : 25 rings ont été ouverts sur 38 (65,8 %), avec un gap important à Katwa et à Beni, 42 ESS décontaminées sur 46 (91,3 %) et 7 ménages sur 36 (19,4 %), aucun des ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; 17 évaluations PCI (score card) ont été réalisées dans 17 ESS avec un score moyen de 31,6 % et la formation de 3 équipes d'ECUMR sur la PCI/WASH/EDS a débuté dans la ZS de Beni avec l'appui de l'OMS.
- **Haut-Uélé** : 3 ESS sur 3 (100 %) ont été décontaminées, dont le CH CECCA 16 et le CS Maman Kahenga à Wamba après le passage d'un cas suspect et le CTE de Pawa après un EDS ; le laboratoire de l'HGR d'Isiro a fait l'objet d'un bio-nettoyage, 2 ESS ont été évaluées (scores de 41,9 % à Isiro et de 24,0 % à Boma Mangbetu) et 29 prestataires briefés, et les travaux de construction des latrines du CTE de Wamba ont débuté avec l'appui de l'OMS. Sur 4 alertes EDS, 2 EDS ont été réalisés (50,0 %) et 2 corps swabés, et un corps intercepté au PoC PK10 (ZS d'Isiro) a été sécurisé.
- **Tshopo**. 42 ESS sur 42 (100 %) et 31 ménages sur 34 (91,2 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures, et 53 ESS sur 103 (51,5 %) ont reçu des kits PCI. Quant aux EDS, sur 8 corps attendus (7 reports et 1 alerte du CTE), 3 ont été swabés (37,5 %) et 2 EDS ont été réalisés (CTE et HGR de Makiso-Kisangani).
- **Bas-Uélé** : 12 ESS sur 12 (100 %) ont été suivies à Viadana (3), Buta (3) et Ganga (6), avec le briefing de 36 prestataires sur 38 (94,7 %) et de 6 hygiénistes sur 6 (100 %) ; la formation de 60 prestataires et de 35 hygiénistes sur la PCI s'est poursuivie à Viadana (J2) avec l'appui de FHI 360.

2.4.2. Défis

- **À la Tshopo**, les intrants PCI et les prestataires formés restent insuffisants, seuls 2 ESS sur 103 (1,9 %) dépassent un score PCI de 80 %, l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani est toujours en panne et les morgues Rekapi I et II manquent de kits de prélèvement et d'EPI. Au Bas-Uélé, l'HGR de Buta et les CS Bomea et Bamaria ne disposent ni de zone à déchets fonctionnelle ni de latrines hygiéniques, les triages des ESS suivies ne sont pas fonctionnels faute de personnel dédié, les poubelles et DLM sont insuffisants et la remontée des alertes de décès communautaires reste faible.

2.4.3. Prise en charge holistique

2.4.4. Principales actions

- **En Ituri**, 45 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 76 sorties, dont 15 guérisons. 360 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits de 35,5 % (26 % pour les lits confirmés et 43 % pour les lits suspects), dont 31 malades critiques ; 343 patients sur 355 (96,6 %) ont reçu un repas chaud, tous les enfants sous LNPE/SLM ont été pris en charge (12/12 au CTE, 6/6 à la crèche et 49/49 dans la communauté) et la prise en charge alimentaire et nutritionnelle a débuté au CT de Lolwa. Le cumul des guéris de la province atteint 1 836.
- **Au Nord-Kivu**, 142 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 116 sorties, dont 8 guérisons. Au total, 519 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 84,2 % (315/374), 84,2 % pour les lits confirmés (169/209) et 84,2% pour les lits suspects (146/165) ; 156 patients (33,1 %) sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT.
- **Au Haut-Uélé**, 9 nouvelles admissions de cas suspects ont été enregistrées contre 2 sorties (1 non-cas et 1 décès confirmé au CTE de Pawa), sans aucune guérison. Au total, 76 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, dont 5 en état sévère ou critique, soit un taux d'occupation de 49,7 % (54/153), 29,6 % pour les lits confirmés et 41,7 % pour les lits suspects ; 57 patients, 68 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds.
- **À la Tshopo**, 1 nouvelle admission d'un cas suspect, une infirmière décédée moins de 3 heures après son arrivée, a été enregistrée contre 7 sorties (6 non-cas et 1 décès). Au total, 15 patients (6 confirmés et 4 suspects) demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de 27,8% (10/36); depuis le début, 393 personnes ont reçu le traitement expérimental, dont 37 cas confirmés, et 357 ont bénéficié de la prophylaxie post-exposition.
- **Au Bas-Uélé**, aucun nouveau cas confirmé n'a été admis ; 10 cas suspects sont isolés dans des centres de transit non normés de Ganga, Poko, Bili, Dakwa, Likati et Limba (ZS de Viadana), et 3 suspects de Buta ont été déclarés non-cas après analyse.

2.4.5. Défis

- **En Ituri**, la faible capacité d'accueil de certains CTE/CT (Mambasa, Jina, Sota Mangala, Mandima et Lolwa), la prise en charge de 31 malades critiques et l'absence d'alimentation pour 12 patients à Mandima demeurent préoccupantes.
- **Au Nord-Kivu**, la saturation des lits suspects (146/165 ; 88,5 %) et la prise en charge de 156 patients (33,1 %) en dehors des CTE/CT demeurent préoccupantes.
- **Au Haut-Uélé**, les incohérences des données de prise en charge et l'absence de corbillard au CTE de Boma Mangbetu demeurent des défis à résoudre.
- **À la Tshopo**, la démotivation de 12 ambulanciers sur 29 (41,4 %) fragilise le transfert des patients.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé, encore en construction, et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.

2.5. Vaccination

2.5.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie dans la ZS de Poko, avec le préenregistrement des leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs, portant le cumul provincial à 1 412 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (10,7 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %), à Ganga (273 ; 20,5 %) et à Poko (150 ; 11,0 %).
- **En Ituri**, les essais cliniques Partners, Oracle et EBO-PEP se sont poursuivis avec l'appui de l'INRB, de Kivu et d'ALIMA, et un protocole de recherche sur l'impact de l'épidémie sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive a été reçu pour analyse.

2.5.2. Défis

En Ituri, la vaccination des PPL et l'étude de l'immunité croisée avec la souche BDBV restent suspendues dans l'attente de l'approvisionnement en vaccin Ervebo par le PEV national.

Au Bas-Uélé, la mise en marche des UCC n'est pas effective et le micro-plan validé ainsi que les fonds de la vaccination ne sont toujours pas disponibles.

2.6. Continuité des Soins

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, l'évaluation du CS Tshopo 2 et du CS Salama a révélé l'absence de zone de triage effective et de dispositif de gestion des déchets (ni incinérateur, ni fosse à ordures, ni fosse à placenta), la non-utilisation du partogramme lors des accouchements, une faible vaccination du personnel au CS Salama (2 agents sur 15 ; 13,3 %) et 5 rendez-vous de CPN manqués sur 16 attendus (31,3 %) ; le plan de travail PCSSE d'octobre et le plan de redressement du CS Ville ont été finalisés, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis.
- **Au Haut-Uélé**, un sondage rapide sur les raisons de la faible utilisation des services de soins a démarré dans l'AS de Kolu (ZS d'Isiro), avec 28 ménages enquêtés sur une centaine ciblés

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 30 840 visites à domicile ont touché 51 032 personnes ; 741 causeries éducatives ont réuni 20 278 personnes, 323 sensibilisations de masse 4 780 personnes, 3 débats communautaires 544 personnes et 12 plaidoyers 24 autorités et leaders ; 34 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 11 émissions organisées. Au total, 346 alertes communautaires, dont 96 décès, ont été notifiées ; 123 feedbacks sur 151 (81,5 %) et 7 incidents sur 8 (87,5 %) ont été résolus dans les 48 heures, et une visite guidée du CTE de Rwampara a été organisée au profit d'une dizaine de RECO de l'AS Dele.
- **Au Bas-Uélé**, 123 visites à domicile ont touché 482 personnes à Ganga et à Viadana, 3 séances de sensibilisation de masse 900 personnes et une émission radio sur la RVA/Aketi 13 859 auditeurs ; 41 prestataires de la ZS de Viadana et 8 prestataires du point de contrôle PK65 ont été briefés, et les 2 alertes communautaires, les 5 feedbacks et l'incident notifiés ont tous été résolus (100 %).
- **Au Nord-Kivu**, 7 790 visites à domicile ont touché 23 427 personnes, 188 causeries éducatives 5 902 personnes et 25 séances de communication de masse 5 051 personnes ; 269 alertes communautaires sur 650 attendues (41,4 %) ont été notifiées, 26 feedbacks sur 34 (76,5 %) et 2 incidents sur 5 (40,0 %) ont été résolus dans les 48 heures et 1 914 personnes sur 4 750 attendues (40,3 %) se sont engagées dans les actions communautaires. La sortie de 8 guéris du CTE de Beni a été couverte par 16 médias, et 60 chefs d'établissement scolaire de Beni ainsi que 111 enseignants de Manguredjipa ont été mobilisés pour la prévention en milieu scolaire.
- **À la Tshopo**, 5 séances de sensibilisation de masse ont touché 15 506 personnes à Bafwasende, Tshopo, Makiso-Kisangani et Lubunga, 217 visites à domicile 1 519 personnes et 3 causeries éducatives 214 personnes ; les 63 alertes communautaires notifiées ont toutes été résolues, 2 feedbacks sur 2 et 2 refus sur 2 ont été levés, et 128 dépliants et 174 affiches ont été distribués.
- **Au Haut-Uélé**, 24 causeries éducatives, 4 séances de sensibilisation de masse et 71 visites à domicile ont touché 1 412 personnes à Isiro et à Wamba ; 52 alertes communautaires, dont 4 décès, ont été notifiées dans 6 ZS et les 7 feedbacks reçus ont été résolus (100 %), la plupart portant sur la communication autour des patients du CTE, et 30 acteurs des médias de la province ont été formés à la CREC en situation d'urgence.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 20 des cas confirmés sur 23 (87,0 %), 46 confirmés en cours de suivi, 93 nouveaux suspects et 676 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; les équipes ont accompagné 70 ménages pour les actions de santé publique et 23 ménages d'enfants séparés et

orphelins sur 25 (92,0 %), soutenu 60 PPL, suivi 11 guéris sur 11 en communauté (100 %), 6 enfants sur 6 en crèche et 31 enfants sur 35 en communauté (88,6 %), réalisé la psychoéducation de 364 personnes (127 hommes, 196 femmes et 41 enfants) avec l'appui de l'UNICEF et annoncé 125 résultats, dont 23 positifs ; 7 ZS sur 9 ayant notifié sont couvertes (77,8 %).

- **En Ituri**, 24 des cas confirmés sur 34 (70,6 %), 91 confirmés en cours de suivi sur 132 (68,9 %), 30 nouveaux suspects sur 45 (66,7 %) et 112 suspects en cours de suivi sur 158 (70,9 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 270 accompagnants et 98 PPL, suivi 18 guéris sur 20 (90,0 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 24 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 27 (88,9 %), réinséré 11 guéris sur 15 (73,3 %) et annoncé 34 résultats, dont 24 positifs
- **À la Tshopo**, en l'absence de nouveau cas confirmé, les 6 confirmés en cours de suivi, le nouveau suspect et les 13 suspects en cours de suivi ont été pris en charge (100 %) ; les équipes ont soutenu 13 PPL et 3 ménages, levé 2 résistances sur 2 autour des ménages des contacts liés à DHKis et réalisé la psychoéducation de 121 personnes (52 contacts à Makiso-Kisangani, 17 à Mangobo, 3 à Lubunga, 36 accompagnants au CTE Météo et 13 PPL) ; 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (71,4 %).
- **Au Haut-Uélé**, 5 cas confirmés récents, 26 confirmés en cours de suivi, 4 nouveaux suspects et 20 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 49 accompagnants, 82 PPL (dont 25 membres de la coordination nationale), 10 enfants séparés en communauté et 15 membres de ménages, appuyé 3 EDS et annoncé 37 résultats, dont 8 positifs
- **Au Bas-Uélé**, 5 PPL, 6 membres de ménages et de la communauté et 2 contacts ont été soutenus, 1 guéri déchargé est suivi, 1 réticence a été levée et 3 résultats ont été annoncés (tous négatifs) ; une descente conjointe avec la CREC a été menée auprès de l'époux du dernier cas confirmé de Limba pour son adhésion au traitement compassionnel.

2.8.2. Défis

- **En Ituri, seules** 14 ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et la ZS de Mandima n'a aucune couverture SMSPS, ce qui impose de renforcer les capacités des psychologues et des APS/TPS pour assurer les interventions autour des cas.
- **Au Bas-Uélé**, la couverture SMSPS reste embryonnaire, les activités venant à peine de démarrer dans la ZS de Viadana.
- **Au Haut-Uélé**, la mobilité des APS reste difficile à Wamba et à Boma Mangbetu, les kits nutritionnels manquent pour les nourrissons sevrés à Wamba et à Isiro, le pilier ne dispose pas de matériel informatique et la remontée des données reste faible à Boma Mangbetu et à Pawa
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des unités de communication et des motos pour les déplacements du pilier.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, réception des intrants PCI offerts par FHI 360, déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active, et poursuite de la réhabilitation de la salle de réunion (fixation des fenêtres) et des bureaux Hygiène et Enseignement de la DPS avec l'appui de l'OMS, ainsi que de la construction du CTE de l'HGR de Buta, dont les murs de pourtour sont achevés ; la DPS ne dispose plus d'aucun stock de gasoil.
- **À la Tshopo**, suivi de la construction du CTE de Bafwasende, de l'extension du CTE Météo et de l'isolement de Konga-Konga, dont les travaux reprendront après la finalisation des caniveaux, déballage des médicaments PHATKIN à Bafwasende, début des inventaires au dépôt et appui à la mobilité des piliers PCI, PEC, Communication et PoE/PoC ainsi qu'au retour à Bafwasende des contacts à haut risque ; le besoin en mobilité des ZS reste estimé à 154 motos.
- **Au Haut-Uélé**, 6 courses d'ambulance ont permis de transporter 6 patients à Pawa (2), Wamba (2), Isiro (1) et Boma Mangbetu (1)

2.10. Sécurité

2.11. Principales actions

- **À la Tshopo**, les résistances communautaires aux investigations, aux prélèvements, à l'isolement et au transfert au CTE persistent, et des agressions physiques contre les équipes d'intervention rapide continuent d'être rapportées
- **Au Bas-Uélé**, la situation sécuritaire est restée calme sur les sites d'intervention ; les activités de riposte ont été sécurisées et des échanges ont eu lieu avec les responsables des services de sécurité, de l'ANR et de la DGM sur l'appui à la recherche d'éventuels contacts dissimulés dans la communauté
- **Au Nord-Kivu**, l'équipe de décontamination a été agressée par la population au CS de Boikeni avant d'être libérée par les services de sécurité, qui ont interpellé les auteurs ; les équipes EDS et PCI ont été escortées pour les enterrements aux cimetières de Paidia (ZS de Beni) et de Lusovovo (ZS de Katwa), le swab d'un corps au CH Kivika (ZS de Katwa) et la décontamination des CM La Modestie et Baraka ainsi que d'un ménage dans l'AS de Kasanga (ZS de Beni).

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, la formation des formateurs sur la PSEAH a démarré dans la ZS de Bunia avec 27 participants (19 femmes et 8 hommes), et des sessions de formation ont réuni 61 enseignants et membres des comités de parents à Komanda (23 femmes et 38 hommes) ainsi que 22 membres des COPA, enseignants, leaders communautaires et associations féminines à Tchomia (8 femmes et 14 hommes) ; les sensibilisations ont touché 3 502 élèves et personnels de cinq écoles d'Aru, 22 leaders communautaires et traditionnels à Lita et 8 peintres à Bunia, et 72 staffs ont été briefés et ont signé le code de bonne conduite. L'affichage des messages et la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongwalu, Mambasa et Fataki.
- **Au Nord-Kivu**, des briefings sur la PSEAH ont été réalisés dans les ZS de Beni, Butembo et Katwa, et 1 097 personnes ont été sensibilisées sur la PSEA et les voies de signalement (49555 et 151) à Beni (168), Butembo (411), Katwa (465), Mutwanga (21) et Biena (32), avec la distribution de 187 dépliants et 10 affiches.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS sur 7 (28,6 %) ont rapporté leurs activités PSEA ; en Ituri, seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement, les activités ne couvrent pas encore toutes les ZS touchées et seuls 3 partenaires (OMS, IMC et Save the Children) rapportent leurs activités PSEA.

MESSAGES CLÉS

- Dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé, il s'observe une transmission communautaire active tandis qu'une notification sporadique est observée dans la province de la Tshopo.
- 2. Au cours des dernières 24 heures.
- Au cours des dernières 24 heures, tous les cas suspects (100,0%) ont été investigués ; des performances consolidées au regard des données transmises par les provinces. Cependant, le suivi des contacts demeure fluctuant (80,0 % vs 82,0 %) et mérite une attention particulière afin d'éviter des chaînes de transmission non contrôlées. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider les actions PCI et CREC au niveau des communautés tout en offrant des soins de qualité dans les structures de prise en charge dédiées avec des capacités d'accueil adéquates.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd